Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

À RETENIR

- RIV = MRP (molécule vectrice radiomarquée) à tropisme sélectif pour un tissu cible, émettant β^- ou α → lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau) ; base du **théranostic**.
- **^{131}I-mIBG** : NB stade III–IV > 1 an, phéo/paragangliome, CMT, carcinoïde ; **444 MBq/kg** (NB) ou **3,7–18,5 GBq** ; blocage thyroïdien ; perfusion lente sous surveillance TA/FC ; jamais de sérum salé.
- **TNE** : ^{177}Lu-DOTATATE **7,4 GBq × 4 cycles / 8 semaines** ; Krenning ≥ 2 ; arrêt des analogues froids **6 semaines** avant ; acides aminés (arginine/lysine **25 g**) pour protéger le rein.
- **^{177}Lu-PSMA** (mCRPC) : **7,4 GBq/cycle**, 6 cycles toutes les **6–8 semaines** ; SUV méta > **1,5 × foie** ; effet secondaire majeur : xérostomie. ^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg** / 8 semaines.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : α, analogue du Ca^{2+}, T½ **11 j**, **55 kBq/kg** × 1/mois × 6 ; mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques sans métastases viscérales ; élimination digestive (CI : Crohn/RCUH).
- **Palliation osseuse** : ^{89}Sr (T½ **50 j**, **150 MBq**, prostate), ^{153}Sm-EDTMP (T½ **2 j**, **37 MBq/kg**, γ 103 keV), ^{186}Re-HEDP (T½ **3,7 j**).
- **Zevalin** (^{90}Y-ibritumomab, anti-CD20) : LNH folliculaire en rechute ; rituximab J1 et J8 ; **11–14 MBq/kg** ; CI si infiltration médullaire > **25 %**.
- **SIRT** : ^{90}Y-microsphères **30–60 µm** dans l'artère hépatique ; test ^{99m}Tc-MAA **150 MBq** ; poumon < **30 Gy** ; > **105 Gy** (verre) / > **120 Gy** (résine).
- **Radiosynoviorthèse** : colloïdes β^- (**2–5 µm**) — ^{90}Y genou, ^{186}Re grosses/moyennes articulations, ^{169}Er petites articulations ; immobilisation **2–3 j** ; nouvelle RSO après **≥ 6 mois**.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse**.

I. Introduction

- **Définition** : technique de radiothérapie se basant sur l'administration (**IV ou per os**) d'un MRP (**molécule vectrice radiomarquée**) se caractérisant par un **tropisme** vers les cellules d'un tissu cible (tissu pathologique ou tumoral), sélectivement et spécifiquement.
- **Mécanisme d'action** : émission de **rayonnements ionisants** (β^- ou α) par le radio-isotope, induisant une lyse cellulaire du tissu cible en provoquant des dommages au niveau de l'ADN de manière **directe** ou **indirecte** (radiolyse de l'eau).
  - Annotation au crayon : effet *bystander*, effet abscopal.
- Il existe **2 formes** de RIV :
  1. **Radio-immunothérapie** : anticorps (Ac) radiomarqués.
  2. **Radiopeptidothérapie** : peptides radiomarqués.
- **Avantages** :
  - Très **spécifique** d'un type cellulaire (tumeur ou tissu cible).
  - Traitement de type **systémique**, intéressant pour les cibles disséminées (métastases) et les lésions de petite taille.
- **Notion de théranostic** : concept associant le diagnostic et la thérapie, permettant la visualisation d'une cible par des MRP diagnostiques avant son traitement par un MRP thérapeutique ciblant la même structure ; son intérêt réside dans la mesure et la quantification des lésions cibles **avant, pendant et après** le traitement afin d'évaluer la réponse thérapeutique.
  - C'est l'outil le plus précis à ce jour en matière de **médecine personnalisée**.

II. RIV en oncologie

1. Irathérapie à l'iode 131 dans le traitement du CDT et de l'hyperthyroïdie

- Voir cours CDT et cours hyperthyroïdie (HT).

2. mIBG thérapeutique : ^{131}I-mIBG

A. Indications

1. **Neuroblastome stade III ou IV**, âge > 1 an
   - Stade III : traverse la ligne médiane ou ganglions/tissu controlatéral(aux).
   - Stade IV = M1.
2. **Phéochromocytome ou paragangliome** inopérable ou multimétastatique.
3. **Carcinome médullaire de la thyroïde** métastatique ou récidivant.
4. **Tumeur carcinoïde** inopérable.

→ **Seule** ou **avec topotécan**.

B. Contre-indications

CI absolues	CI relatives
1. Grossesse et allaitement. 2. Espérance de vie **< 3 mois** (sauf si douleurs osseuses réfractaires au traitement). 3. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.	1. Incontinence urinaire. 2. DFG **< 30 mL/min**. 3. Toxicité rénale ou hématologique progressive suite à un traitement antérieur. 4. Myélodépression : Hb **< 9·10⁹/L** **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L*, plaquettes **< 100·10⁹/L**.

C. MRP : ^{131}I-mIBG

> **NB** — Pas d'AMM pour les neuroblastomes (NB).

Item	^{131}I-mIBG
Nomenclature	Méta-iodo-benzyl-guanidine.
Radionucléide (^{131}I)	• Origine : **double** = fission de l'uranium 235 (^{235}U) ou bombardement neutronique du tellure stable (Te). • Période physique : **8 jours** → décroît en ^{131}Xe. • Émission **mixte** : Eγ = **364 keV** ; Emax β⁻ = **606 keV (0,6 MeV)** ; Emoy β⁻ = **0,2 MeV**. • Parcours : **0,8 mm**.
Propriétés chimiques de la molécule vectrice	Molécule dérivée du brétylium et de la guanidine, **analogue structural de la noradrénaline** (norépinéphrine ; monoamine sécrétée par la médullosurrénale).
Mécanisme de fixation	Passage transmembranaire selon **2 processus** : **Uptake I** : • **Transport actif** par les transporteurs membranaires de la NA (NET) (échange catécholamine/Na^+). • ATP-dépendant et Na^+-dépendant. • Saturable. • Haute affinité / faible capacité. • Sensible à l'ouabaïne. **Uptake II** : • **Diffusion passive**. • Na^+-indépendant. • ATP-indépendant. • Température-dépendant. • Non saturable. • **Prédomine** dans le passage transmembranaire de la mIBG. **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)* • Insensible à l'ouabaïne.
Activité administrée	• Neuroblastome : **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**). • Phéochromocytome / paragangliome : **3,7 à 18,5 GBq** (**100–500 mCi**).
Dosimétrie	Dosimétrie tumorale : **5 à 300 Gy**, sans dépasser les **2 Gy** à la moelle osseuse (MO).

Rappel : k = 10^3 ; M (MBq) = 10^6 ; G (GBq) = 10^9.

D. Procédure d'administration du traitement

Avant la cure

- Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG ou ^{131}I-mIBG (dose diagnostique) initiale pré-thérapeutique de référence.
- **Blocage de la thyroïde** :
  - Lugol 5 % : **1 goutte/kg/j** en 3 prises, **2 j avant** et **10 à 15 j après**.
  - Perchlorate de potassium : gélule de **400 mg** (2 gélules/j), 1 h avant et 10–15 j après.
  - Iodure de potassium : gélule de **130 mg** (1 gélule/j), 1 j avant et 10 à 15 j après.
- **Arrêt des médicaments interférant avec la mIBG** : antihypertenseurs (β-bloquants, inhibiteurs calciques, anti-HTA centraux), antidépresseurs tricycliques et sympathomimétiques.

Pendant la cure

- Perfusion IV de ^{131}I-mIBG (**45 min – 4 h**) + SGI (**jamais de sérum salé**).
- Surveillance de la FC et de la TA : avant, pendant et après la perfusion, puis au moins 2 fois/j durant les jours suivants (+++ si tumeurs sécrétantes).
- Si pic hypertensif : ① arrêt temporaire de la perfusion ; ② administration de β- ou α-bloquants à courte durée d'action.
- Bonne hydratation avec mictions fréquentes.

Après la cure

- Scintigraphie post-thérapeutique.
- Respect des mesures de radioprotection.

E. Effets secondaires

Précoces	Tardifs
1. Nausées et vomissements. 2. Crises hypertensives par libération des catécholamines. 3. Bouffées de chaleur par libération de sérotonine (tumeurs carcinoïdes). 4. Myélodépression transitoire.	1. Hypothyroïdie (si blocage inadéquat). 2. Insuffisance médullaire persistante (thrombopénie). 3. Cancers radio-induits (leucémie, tumeurs solides), surtout si chimiothérapie associée.

F. Efficacité

- Taux de réponse estimé à **58 %** (annotation : 60 %) pour le neuroblastome.
- Taux de réponse à **40 %** pour les phéochromocytomes et paragangliomes.

Type de réponse	Neuroblastome	Phéochromocytome	CMT
Palliative (symptomatique)	**90 %**	**70 %**	**60 %**
Humorale	**60 %**	**30 %**	**20 %**
Partielle (tumorale)	**30 %**	Rare	Exceptionnelle

3. Radiothérapie interne ciblée aux analogues de la somatostatine (radiothérapie des TNE)

MRP = **peptide** (octréotide) + **agent chélateur** (DOTA, DTPA) + **radionucléide** (^{111}In, ^{90}Y, ^{177}Lu).

A. Indications

- **TNE gastro-entéro-pancréatique** non résécable ou métastatique, progressive, **bien différenciée (G1 ou G2)** (annotation au crayon : Ki67 – IM (index mitotique)).
- **SSTR positives** : score de **Krenning ≥ 2**.

B. Contre-indications

1. Insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 50 mL/min** dans les urines des 24 h).
2. Fonctions hématologiques altérées : Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³**.

3. Insuffisance hépatique sévère : bilirubine totale **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; TP ↓.
4. Insuffisance cardiaque sévère : classe **III ou IV de la NYHA**.
5. Grossesse ou allaitement.

C. MRP

MRP	^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	^{90}Y-DOTATOC (Octréother)
Affinité SSTR (annotation)	SSTR 2 > 4 > 5	SSTR 2 > 3 > 5
Nomenclature	^{177}Lu-DOTA-Tyr3-oxodotréotide	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide
Radionucléide	• Origine **double** → bombardement neutronique de l'^{176}Yb (ytterbium) ou du ^{176}Lu. • Période : **6,7 jours**. • Émission mixte β^- et γ. • Particule β^- : Emax = **0,5 MeV** ; Emoy = **0,166 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle Emoy ≈ 0,13–0,15 MeV* ; parcours **2 mm**. • Rayons γ : **208 keV (11 %)**, **113 keV (6 %)**.	• Origine : ^{90}Sr → ^{90}Y → β^- (générateur). • Période : **2,7 jours (64 h)**. • Émission β^- pure : Emax = **2,27 MeV** ; Emoy = **0,94 MeV**. • Parcours : **12 mm** ou **3,2 mm** ? (max / moyen). • Émission de rayons X de freinage : « **Bremsstrahlung** ».
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	**Analogue structural de la somatostatine** → fixation sur les récepteurs de la somatostatine (SSTR), notamment le sous-type 2 (**SSTR2**), puis **internalisation** du MRP, qui entraîne la mort des cellules tumorales par émission de rayonnements ionisants.	
Activité administrée	**7,4 GBq/cycle** ; **4 cycles**, 1 cycle toutes les **8 semaines**.	**1,8 à 3,7 GBq/cycle**.
Dosimétrie	**2 Gy** à la moelle (dose limitante).	—
Indications	Tumeurs et métastases de **petite taille**. Affinité ↑, tolérance ↑.	Parcours plus long → lésions de **plus grand volume**.

> **^{111}In** (^{111}In-octréotide) : γ = **173 et 245 keV** ; X = **23 keV** ; électrons Auger = **3 keV** ; parcours de l'ordre du µm. Annotation : « produit de réacteur nucléaire » **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron ; le ^{177}Lu est produit en réacteur*.

D. Procédure d'administration

Avant la cure

1. TNE prouvée histologiquement et immunohistochimiquement (G1–G2) + **justification**.
2. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
3. Imagerie isotopique aux analogues de la somatostatine (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) mettant en évidence la captation tumorale ± quantification.
4. Recueil des données des examens précédents (imagerie morphologique… etc.).
5. Préparation du patient :
   - **Protection rénale** par l'administration d'**acides aminés chargés positivement** : **25 g** d'arginine ou de lysine dans **1 L** de perfusion saline, en perfusion pendant **4 ou 6 h**, à débuter **30 à 60 min** avant la cure de radiopeptidothérapie.
     - *Intérêt* : inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale du radiopeptide, et donc diminution de l'irradiation du rein.
   - **Arrêt des analogues froids de la somatostatine** **6 semaines** **avant la cure** (remplacés par la somatostatine à action courte s'il le faut, arrêtée **1 j** avant).
   - Administration d'un antiémétique.

Pendant la cure — possibilité d'un traitement **ambulatoire** (≠ mIBG : hospitalisation).

1. Perfusion IV du MRP via un **cathéter central** pour éviter toute extravasation.
2. Surveillance étroite des fonctions vitales du patient pendant et après la cure.
3. Disponibilité d'un **chariot de réanimation** contenant les médicaments et substances nécessaires pour juguler les éventuels effets ou une exacerbation des syndromes fonctionnels (syndrome carcinoïde, HTA, hypotension, hypoglycémie, déséquilibre électrolytique… etc.).
4. Bonne hydratation et mictions fréquentes.

Après la cure

1. Scintigraphie post-thérapeutique.
2. Respect des RRP (règles de radioprotection).

E. Effet secondaire

- **Toxicité rénale +++**.

F. Efficacité

- Contrôle des symptômes ; amélioration de la qualité de vie ; contrôle de la maladie.
- Contrôle de la maladie = **90 %**.
- Taux de réponse = **42 %**.
- Survie sans progression = **24 mois**.

Perspectives

- L'association à une chimiothérapie radiosensibilisante (5-fluoro-uracile) → ↑ efficacité.
- mIBG → TNE du *midgut*.
- Antagonistes (des SSTR) +++.

G. Mise à jour « RIV et TNE 2025 » (post-it)

- ^{111}In-DTPA-octréotide = ^{111}In-pentétréotide.
- ^{177}Lu-DOTA-TATE = ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate.
- ^{90}Y-DOTA-TOC = ^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide.
- Affinité pour **SSTR2** : ^{90}Y = **2×** l'affinité de l'^{111}In ; ^{177}Lu = **10×** celle de l'^{90}Y → tolérance ↑, toxicité ↓.
- Annotation : traitement = **4** cycles ; retraitement = **2** ; re-retraitement = **2**.
- ^{111}In : Auger = **23 keV**, X = **3 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : inversé par rapport à plus haut — X ≈ 23 keV, Auger ≈ 3 keV.*
- **Indications** : toujours en **RCP multidisciplinaire** ; TNE bien différenciée **G1–G2–G3 (Ki67 < 55 %)**, M1, non résécable ou localement avancée, **SST2 ⊕**, progressive ou symptomatique.
- Arrêter les facteurs de croissance ou l'EPO **2 semaines** avant la RIV.
- **Effets secondaires** :
  - Nausées, vomissements : liés à la perfusion d'acides aminés (AA) → antiémétique.
  - Fatigue.
  - Alopécie.
  - Toxicité hématologique : ↓ plaquettes, ↓ GR…
  - Toxicité rénale : **rare**.
- **Perspectives** : antagonistes de la somatostatine (non internalisés) ; chimiothérapie radiosensibilisante (5-fluoro-uracile).

4. Radiothérapie interne ciblée sur le PSMA

A. Indications

- Patients présentant un **cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC)**, associé à une absorption adéquate des ligands PSMA évaluée et quantifiée par une imagerie pré-thérapeutique (^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-PSMA).

> **Stratégie thérapeutique du cancer de la prostate** (post-it)
> - **Localisé** : surveillance active ou traitement curateur (chirurgie, RTE).
> - **Localement avancé** : chirurgie ou hormono-radiothérapie.
> - **M+** : hormonothérapie.
> - **mCRPC** : hormonothérapie de 2e ligne ; chimiothérapie si symptômes ; **RIV**.

B. Contre-indications

1. Insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min.*
2. Fonctions hématologiques altérées : Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³**.
3. Insuffisance hépatique sévère : bilirubine **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; ASAT/ALAT **> 5N** ; TP.

4. Espérance de vie **< 6 mois**.
5. État de performance **ECOG > 2** (OMS > 2).

C. MRP

Item	^{177}Lu-PSMA	^{225}Ac-PSMA
Nomenclature	PSMA = antigène membranaire spécifique de la prostate = **glutamate carboxypeptidase II**.	
Radionucléide	• Période physique : **6,7 j**. • Émission mixte β^- et γ. • Particule β^- : Emax = **0,5 MeV** ; Emoy = **0,166 MeV** ; parcours **2 mm**. • Rayons γ : **208 keV (11 %)** ; **113 keV (6 %)**.	• ^{225}Ac = actinium. • Origine : cyclotron. • Période physique : **10 j**. • Émission α = **5,9 MeV**. • Parcours = **1,8 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm.*
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	La glutamate carboxypeptidase II est une **glycoprotéine transmembranaire de type II**, hautement exprimée dans le cancer de la prostate.	
Activité administrée	**7,4 GBq/cycle** (**200 mCi**) ; **6 cycles** ; 1 cycle toutes les **6 à 8 semaines**.	**100 kBq/kg/cycle** ; 1 cycle toutes les **8 semaines**.
Dosimétrie	**2 à 9 Gy/cycle** (dose limitante à la MO = **2 Gy**).	—

D. Procédure d'administration du traitement

> **NB** — Intérêt de la TEP-FDG : aspect de **mismatch** = PSMA ⊕ / FDG ⊖ (selon les notes) → **intérêt pronostique**. **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*

Avant la cure

1. Information du patient, consentement éclairé et signé.
2. Recueil de l'ensemble des examens morphologiques effectués.
3. Imagerie isotopique initiale pré-thérapeutique de référence au ^{68}Ga-PSMA ou au ^{18}F-PSMA avec **quantification** : **SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique**.
4. Bilan rénal, hépatique, FNS.

Pendant la cure (aucune préparation particulière — annotation au crayon)

1. Perfusion IV du MRP : **10 min**.
2. Surveillance des constantes vitales.

Après la cure

1. Scintigraphie post-thérapeutique si traitement au ^{177}Lu-PSMA, à **4 h, 24 h, 48 h et 120 h** post-cure.
2. Antiémétique.
3. Respect des RRP : collecte des urines **6 h** post-injection.

E. Effets secondaires

1. **Xérostomie**.
2. Myélodépression.
3. Troubles rénaux, voire insuffisance rénale.

Fixation physiologique (F ⊕) du PSMA : glandes salivaires, glandes lacrymales, reins, grêle, foie ?, rate ?, cancer du sein, vessie, thyroïde.

F. Efficacité

1. Baisse significative du taux de PSA sérique chez la plupart des patients.
2. ↓ des douleurs avec meilleure qualité de vie.
3. Réduction de la taille des lésions cibles.

5. RIV dans le traitement des métastases osseuses

MRP à visée osseuse (post-it)

- **Strontium 89** : ^{89}Sr = **Metastron** → β^- ; indication : **prostate**.
- **Samarium 153** : ^{153}Sm-EDTMP = **Quadramet** → β^- + γ ; indication : cancers en général.
- **Radium 223** : ^{223}Ra = **Xofigo** → α ; indication : prostate ([illisible]).
- Effets : ↓ douleur + ↑ qualité de vie.
- Concentration là où l'os se renouvelle +++ (épargne l'os sain).

A. Indications (prostate)

- Cancer de la prostate résistant à la castration (mCRPC) avec **métastases osseuses symptomatiques**, **sans métastases viscérales connues**, inéligible à tout traitement systémique disponible, ou en progression après **2 lignes** de traitement systémique.

B. Contre-indications

Absolues	Relatives
1. Association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la **prednisone**. 2. Présence de métastases viscérales. 3. Maladie de Crohn – RCUH.	1. Insuffisance médullaire. 2. Compression médullaire. 3. Métastases osseuses asymptomatiques. 4. Oligo- ou mono-métastase osseuse ostéoblastique. Pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6 à 8 semaines**.

C. MRP : ^{223}Ra

Item	$^{223}RaCl_2$
Nomenclature	Dichlorure de radium $^{223}RaCl_2$ (**Xofigo** ou Alpharadin).
Radionucléide (^{223}Ra)	• Origine : bombardement neutronique du ^{226}Ra. • Période physique : **11 j**. • Émission : **α** ; énergie = **5 à 7,5 MeV**. • Parcours **< 100 µm (0,1 mm)**.
Mécanisme d'action	^{223}Ra = **cation divalent analogue structural du Ca^{2+}**.
Activité administrée	**55 kBq/kg/cycle** ; **1 cycle/mois pendant 6 mois**.
Dosimétrie	— (non renseignée dans les notes)

D. Procédure d'administration

Attention ! — Élimination **digestive** → CI si RCUH ou maladie de Crohn.

Avant la cure

1. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
2. Scintigraphie osseuse préalable aux biphosphonates technétiés ou TEP au ^{18}F-NaF initiale pré-thérapeutique de référence.
3. Recueil des données des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
4. **Examen neurologique complet** afin de mettre en évidence une compression médullaire.

Pendant la cure

1. Injection **IV lente pendant 1 min** de **55 kBq/kg**.
2. Administration concomitante de **biphosphonate** ou de **dénosumab** afin de réduire le risque fracturaire.

Après la cure

1. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ± SPECT/CT, ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF d'évaluation de fin de traitement, **3 mois** post-cure.
2. Respect des règles de radioprotection.

E. Effets secondaires

1. Nausées et vomissements.
2. Réaction au site d'injection.
3. Thrombopénie, leucopénie et rarement lymphopénie.

F. Efficacité

1. ↑ de la survie et/ou de la qualité de vie.
2. Réduction des douleurs osseuses.

6. Traitement palliatif des métastases osseuses

A. Indications (autres cancers ?)

- **Métastases multiples ostéoblastiques** d'un cancer de la prostate (annotation : sein ?), **hyperfixantes** à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates, avec :
  1. Douleurs réfractaires à un traitement antalgique bien conduit.
  2. Douleurs récurrentes dans une zone traitée préalablement par une RT externe.

B. Contre-indications

- **Absolues** : grossesse et allaitement.
- **Relatives** :
  1. **SBS** (*super bone scan* : infiltration ostéomédullaire métastatique diffuse à la scintigraphie osseuse).
  2. Insuffisance médullaire : Hb **< 9** ; plaquettes **< 100·10³** ; GB **< 3·10³**.
  3. Insuffisance rénale sévère : DFG **< 30 mL/min**.
  4. Espérance de vie **< 3 mois**.

  Annotation : chimiothérapie, RTE.

C. MRP

MRP	$^{89}SrCl_2$	^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	^{186}Re-HEDP
Rythme (annotations)	1 cure / **12 semaines** ; prostate uniquement	1 cure / **8 semaines**	—
Nomenclature	Chlorure de strontium	Éthylène-diamine-tétraméthylène-phosphonique	Hydroxy-éthylène-diphosphonate
Radionucléide	**Strontium** ^{89}Sr • Période physique : **50 j**. • Émission β^- : Emax = **1,46 MeV** ; Emoy = **0,58 MeV**. • Parcours = **2,4 mm**.	**Samarium** ^{153}Sm • Période : **2 j**. • Émission mixte γ et β^-. • β^- : Emax = **0,64 MeV** ; Emoy = **0,23 MeV** ; parcours = **0,6 mm**. • γ = **103 keV**.	**Rhénium** ^{186}Re • Période : **3,7 j**. • Émission mixte β^- et γ. • β^- : Emax = **1,07 MeV** ; Emoy = **0,35 MeV** ; parcours = **1,1 mm**. • γ = **137 keV**.
Mécanisme de fixation	• **Analogue du Ca^{2+}**, absorbé au niveau des métastases ostéoblastiques. • Excrétion urinaire **80 %**. • Taux d'excrétion urinaire inversement proportionnel à l'étendue des métastases.	• Fixation par **absorption aux cristaux d'hydroxyapatite**, en fonction du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique. • Rapport d'absorption métastase/os normal : **5/1**. • Élimination urinaire **40 %**, en fonction de l'étendue des métastases.	Idem que pour le ^{153}Sm-EDTMP.
Activité et dosimétrie	A = **150 MBq** (**1,5 à 2 MBq/kg**) ; D = —	A = **37 MBq/kg** ; D = —	A = **1,29 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; D = —
Efficacité	Comparable à la RT externe.	↓ de la douleur dans **80 %** ; ↓ de la masse tumorale osseuse.	↓ de la douleur de **60 à 80 %**.
Effets secondaires	• Exacerbation de la douleur pendant **48 h**. • Thrombopénie réversible. • Myélotoxicité.	• Toxicité médullaire avec thrombopénie et leucopénie transitoires, atteignant son maximum à la **4e semaine** ; récupération en **6–8 semaines**. • Poussée (douloureuse) temporaire : **10 %**, entre **24 et 72 h**.	

7. Radio-immunothérapie pour le lymphome non hodgkinien

A. Indication

- **Lymphome non hodgkinien CD20⁺, folliculaire**, en rechute ou réfractaire après traitement par **rituximab**.

B. Contre-indications

1. Grossesse et allaitement (Ac monoclonal IgG pouvant traverser le placenta et sécrété dans le lait maternel).
2. Hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium.
3. Toxicité hématologique (plaquettes **< 100·10⁹/L**, neutrophiles **< 1 500/mm³**).
4. Infiltration médullaire de plus de **25 %**.
5. ATCD de greffe de moelle osseuse ou de cellules souches — CI relative.
6. Enfants et adolescents de moins de **18 ans** — CI relative.

C. MRP

Item	^{90}Y-ibritumomab tiuxétan
Nomenclature	Yttrium-ibritumomab (**Zevalin**).
Radionucléide (^{90}Y)	• Période physique : **2,7 j = 64 h**. • Émission β⁻ : Emax = **2,27 MeV** ; Emoy = **0,94 MeV**. • Parcours = **3,6 mm** ? / **11 mm**. • Émission de rayons X de freinage (**Bremsstrahlung**).
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	• **Ac monoclonal de souris anti-CD20**. • Fixation hautement sélective sur les cellules malignes ; émission de β⁻ (rayonnements ionisants) → cytolyse tumorale par endommagement de l'ADN.
Activité administrée	**11 à 14 MBq/kg** ; IV lente pendant **10 min** (**1 mL/min**).
Dosimétrie	— (non renseignée dans les notes)

D. Procédure de réalisation du traitement

Avant la cure

1. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
2. Imagerie TEP-TDM au ^{18}F-FDG pré-thérapeutique de référence.
3. **Prétraitement au rituximab à J1 et J8** (intérêt : éliminer les lymphocytes B circulants et optimiser la biodistribution de l'^{90}Y-ibritumomab).
4. Test de détection d'Ac humains anti-souris (HAMA).

Pendant la cure

- Administration IV **à J8** de l'^{90}Y-ibritumomab.

Après la cure

1. Imagerie TEP-FDG d'évaluation.
2. Respect des RRP.

E. Effets secondaires

1. Fièvre et frissons liés à la perfusion du rituximab.
2. Myélotoxicité transitoire.
3. Réactions anaphylactiques dans **< 1 %** des cas.
4. Thrombopénie et neutropénie légères à sévères.

F. Efficacité

1. Réponse globale dans **94 %** des cas, avec **58 %** de réponse complète.
2. L'yttrium-ibritumomab est plus efficace que le rituximab non radiomarqué.

8. Radioembolisation des tumeurs hépatiques malignes : SIRT

- **Radioembolisation ou SIRT** = radiothérapie interne sélective (*selective internal radiation therapy*).
- **^{90}Y-microsphères** : **30–60 µm**.
- Injection dans l'**artère hépatique**.
- Activité spécifique au patient.

A. Mécanisme d'absorption

- Les lésions hépatiques sont alimentées par le **flux artériel** (contrairement au parenchyme normal).
- Les ^{90}Y-microsphères sont **piégées dans les capillaires hépatiques** au lit des tumeurs.
- Dose absorbée délivrée aux tumeurs en épargnant le parenchyme sain.

B. Indications

- Cancer du foie non résécable, primitif ou métastatique : **CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques des TNE ou du CCR** (après RCP).
- Néo-adjuvant : avant résection ou transplantation.

C. Contre-indications

- **Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 1 mois**.
- **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale aiguë ou sévère (**< 30 mL/min**) ; maladie pulmonaire grave.
- **CI au cathétérisme (KT)** : trouble de la crase sanguine ; allergie au PDC ; shunt pulmonaire ; anomalie vasculaire.

D. Procédure

- Angiographie préopératoire **1 à 2 semaines** avant le traitement.
- Hospitalisation la veille avec une bonne hydratation.
- Après angiographie réussie : « enroulement » (*coiling*) du système vasculaire, contrôle de la position du KT.
  - → Dose d'essai de **150 MBq** de ^{99m}Tc-MAA ; SPECT/CT **60 min** après : poumons + abdomen.
- IPP recommandés pendant **6 semaines**.
- Si dépôts extrahépatiques → surveillance.

> **Deux phases** (post-it)
>
> 1. **Phase de test thérapeutique** : ^{99m}Tc-MAA → recherche d'un passage extrahépatique, d'un shunt pulmonaire… (= **CI absolue** si présents).
>   - Se fait en salle de radiologie : artériographie avec repérage des artères nourricières des lésions cibles → positionnement du KT → injection de MAA-^{99m}Tc (le KT doit être dans la même position que pour le traitement).
>   - Scintigraphie après **1 h** = planaire + SPECT abdominale, afin de **calculer le shunt**, rechercher un éventuel passage des MAA dans le pancréas, l'estomac… et **vérifier le ciblage de la tumeur**.
>   - **Foie ciblé < 70 % du foie total**.
>   - **Poumon < 30 Gy**.
> 2. **Phase de traitement** : ^{90}Y-microsphères ; on refait l'angiographie avec le KT dans la même position.
>   - Dose injectée : selon la dosimétrie, la masse de la tumeur…
>   - Imagerie post-thérapeutique : l'^{90}Y émet des **β^+** (NB) → possibilité de quantification, ou SPECT, car le RN se distribue dans le tissu tumoral et le tissu non tumoral autour.
>   - **Radioprotection +++**.

E. Dosimétrie

- **> 105 Gy** : microsphères de **verre**.
- **> 120 Gy** : microsphères de **résine**.

F. Efficacité

- Résultats compétitifs par rapport au traitement conventionnel.
- À l'heure actuelle : indiquée dans le cadre de **sauvetage** ; traitement de 1re intention des métastases du cancer du côlon ?

G. Effets secondaires

- Fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- Rares (**< 1 %**) → pancréatite…

^{131}I-Lipiodol

- **1,1 GBq/mL**.
- Injection intra-artérielle hépatique.
- Envisagé seulement en cas d'échec des traitements conventionnels.

9. Traitement des craniopharyngiomes

- ^{90}Y-colloïdes.

10. FAPI-thérapie

- (Titre seul dans les notes, sans contenu.)

III. Hyperthyroïdie – Radiosynoviorthèse

(I) Hyperthyroïdie : voir cours HT. (II) Radiosynoviorthèse (RSO) : ci-dessous.

A. Définition

- **Radiosynoviorthèse** : technique utilisée pour le traitement des **épanchements articulaires récurrents** par **injection intra-articulaire** d'un radio-isotope **émetteur β^-**, provoquant la lyse de la membrane synoviale pathologique.
- Constitue une **alternative thérapeutique** après un traitement médical systémique ou chirurgical dont les résultats cliniques ne sont pas optimaux.

B. Indications

1. Pathologies non inflammatoires

1. **Synovite villonodulaire pigmentée**.
2. **Hémarthrose récidivante (hémophilie)** :
   - ≥ **3 en 6 mois**.
   - ↓ de la fréquence des saignements (effet anti-angiogénique).
   - **Grade I** : synovite transitoire ≥ 3 en 6 mois, sans séquelles post-saignement → **RSO +++**.
   - **Grade II** : synovite permanente avec hypertrophie articulaire, épaississement synovial et limitation de mouvement → RSO élective.
   - **Grade III** : atrophie chronique (grade II + déformation axiale + atrophie musculaire) → RSO élective.
   - **Grade IV** : ankylose osseuse ou fibreuse → **pas de RSO**.
3. **Arthrose active**.
4. **Synovite après remplacement prothétique** : après échec du traitement bien conduit, et en l'absence d'infection ou de descellement (annotation : « SO – S ou LM » = scintigraphie osseuse, scintigraphie aux leucocytes marqués).

2. Pathologies inflammatoires (rhumatismales)

1. **Arthrite rhumatoïde** :
   - Si échec thérapeutique après **6 mois** de traitement médical à **dose maximale** associé à des infiltrations de CTC.
   - Limite les déformations articulaires invalidantes.

2. **Arthrite indifférenciée**, arthrite psoriasique, SPA.

C. Contre-indications

1. Grossesse et allaitement (contraception **4 à 6 mois**).
2. Enfants en pleine croissance osseuse.
3. Rupture d'un kyste synovial (aspiration écho-guidée **2 j** avant).
4. Hémarthrose massive.
5. Arthrite infectieuse.
6. Infections cutanées locales.
7. Articulations instables du genou, séquestrations ou destruction sévère.

D. Radiopharmaceutiques

- MRP utilisé sous **forme colloïdale** (**2–5 µm**) de façon à permettre au radiotraceur d'être **phagocyté par les macrophages** en place et de s'établir au niveau des **couches superficielles** de la synoviale inflammée (pannus).

MRP	Énergie	Période	Dose	Articulation	Parcours / taille
Yttrium 90 (silicate, citrate)	β max = **2,27 MeV**	**2,7 j**	**5–6 mCi** ; dosimétrie = 100 Gy/MBq	**Genou**	P = **3,6 mm** ; T = 10 nm
Sulfate de rhénium 186 (^{186}Re)	β = **1,02 MeV** ; γ = **137 keV**	**3,7 j**	**3 mCi** **2 mCi** **1–2 mCi** **3,7 mCi** **1 mCi** **2 mCi**	**Épaule** **Coude** **Poignet** **Hanche** **Tarse** **Cheville**	P = **1,2 mm** ; T = 5–10 nm
Citrate d'erbium 169 (^{169}Er)	β = **0,3 MeV** ; γ = **80 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	**9,4 j**	**0,6 µCi** **[à vérifier]** *à vérifier : probablement 0,6 mCi* **0,5 mCi** **0,4 mCi**	**MCP** **IPP** **IPD**	P = **0,3 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm* ; T = 10 nm

- Apparaît ensuite une **fibrose synoviale** avec ↓ des signes inflammatoires et reconstitution d'une nouvelle synoviale.

E. Procédure

Préparation

1. ATCD d'injection intra-articulaire de CTC n'ayant pas entraîné d'effet antalgique ; recours fréquent aux antalgiques.
2. Radiographie standard : atteinte osseuse ou cartilagineuse → CI.
3. Échographie – IRM – scintigraphie osseuse.
4. **Délai entre RSO et** :
   - Arthroscopie ou chirurgie articulaire : **6 semaines**.
   - Nouvelle RSO : minimum **6 mois**.
   - Ponction articulaire : **2 semaines**.
5. Information du patient : procédure ; **réponse retardée** au traitement (plusieurs semaines, voire mois) ; exacerbation de la douleur les jours suivants (injection de CTC en même temps).

Réalisation

- Asepsie rigoureuse.
- Sous scopie conseillée.
- Désinfection de la région articulaire.
- Aspirer le liquide synovial + instillation de **10 à 20 cc** de SSI.
- Placer un robinet 3 voies : seringue du RP, seringue de CTC.
- Mobiliser l'articulation pour répartir la solution (CTC → ↓ l'hypervascularisation secondaire à l'inflammation locale + ↓ le phénomène de fuite).
- **Immobilisation pendant 2 à 3 j** (bandage ou attelle) pour minimiser le risque de migration du produit.

- Scintigraphie : distribution du RP.

F. Effets secondaires

1. Hémorragie locale.
2. Extravasation du produit.
3. Infection.
4. Radionécrose.
5. Nécrose cutanée.
6. Trajet fistuleux.
7. Fièvre.
8. Nausées, vomissements.
9. Allergie.
0. Risque thrombo-embolique du fait de l'immobilisation.

> **NB**
>
> - **Image scintigraphique avant libération du patient** : rayons γ pour l'^{169}Er et le ^{186}Re ; rayonnement de **Bremsstrahlung** pour l'^{90}Y (ou ajouter du ^{99m}Tc).
> - **Scintigraphie osseuse à 3–4 mois** → 3 temps : réévaluer l'inflammation.

Avantages par rapport à la synovectomie chirurgicale

1. Même efficacité.
2. Coût moindre.
3. Ambulatoire.
4. Répétitivité.
5. Risque hémorragique moindre dans l'hémophilie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de passage transmembranaire prédominant de la mIBG ?	Selon les notes, l'uptake II : diffusion passive, Na^+- et ATP-indépendante, non saturable, insensible à l'ouabaïne (à vérifier : la captation spécifique tumorale repose surtout sur l'uptake I/NET).
2. Quelles activités de ^{131}I-mIBG pour un neuroblastome et pour un phéochromocytome/paragangliome ?	444 MBq/kg (12 mCi/kg) ; 3,7 à 18,5 GBq (100–500 mCi).
3. Comment protège-t-on le rein lors de la radiothérapie des TNE ?	Acides aminés chargés positivement (25 g arginine/lysine) perfusés 4–6 h, débutés 30–60 min avant : inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale.
4. Schéma d'administration du ^{177}Lu-DOTATATE ?	7,4 GBq/cycle, 4 cycles espacés de 8 semaines ; dose limitante 2 Gy à la moelle.
5. Quel critère TEP autorise le traitement par ^{177}Lu-PSMA ?	SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique (^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA).
6. Activité et rythme du ^{223}Ra (Xofigo) ? Pourquoi CI en cas de RCUH/Crohn ?	55 kBq/kg, 1 injection/mois pendant 6 mois ; élimination digestive.
7. Seuils de la phase test MAA avant SIRT ?	Foie ciblé < 70 % du foie total ; dose pulmonaire < 30 Gy ; pas de passage extrahépatique.
8. Quel radionucléide pour la RSO du genou, de la hanche, des IPP ?	Genou : ^{90}Y ; hanche (et épaule, coude, poignet, tarse, cheville) : ^{186}Re ; IPP (MCP, IPD) : ^{169}Er.

Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs

Additif : Saclay 2022–2023 « RIV » ; tableaux de synthèse oncologique et non oncologique

À RETENIR

- RIV = traitement des tumeurs par rayonnements ionisants via des **sources non scellées** : administration locale (synoviorthèse, radioembolisation) ou systémique (vecteur spécifique, tropisme d'organe).
- Vecteur idéal : fixation tumorale intense, rétention prolongée, clairance rapide des tissus sains → rapport tumeur/tissu sain élevé.
- Dosimétrie en RIV ≠ RTE : pas de relation simple activité / dose absorbée / effet → connaître la biodistribution (tissus sains et tumoraux).
- Théranostic : **une cible, un vecteur, deux radionucléides**.
- Sélection : le bon patient, la bonne maladie (évolutive mais pas flambante, pas trop tard), les bonnes lésions (surexprimant la cible, sans contingent peu différencié).
- Palliation osseuse : ^{89}Sr (T½ **50,4 j**, 4 mCi = **150 MBq**, réinjection **12 semaines**), ^{153}Sm-EDTMP (T½ **1,93 j**, **37 MBq/kg**, **8 semaines**), ^{223}Ra (T½ **11,4 j**, **55 kBq/kg**/mois × 6).
- Prérequis biologiques (palliation osseuse) : Hb > **9**, PNN > **1 500**, plaquettes > **100 000**, clairance > **50 mL/min** ; CI si espérance de vie ≤ **4 semaines**.
- Hyperthyroïdie : dose « antitoxique » **60–90 Gy**, ablative **100–300 Gy** ; empirique **5–20 mCi** selon la masse ; A(MBq) = M × D / (TF % × Teff × 0,04), Teff = **5,8 j**.

I. Introduction

- **RIV** : traitement des tumeurs par les rayonnements ionisants via l'administration de **sources non scellées**.
  - **Administration locale** : ① synoviorthèse ; ② radioembolisation.
  - **Administration systémique** (tropisme tumoral) : ① vecteur spécifique ; ② tropisme spécifique d'organe.
- Qualités recherchées :
  - Fixation tumorale intense.
  - Rétention prolongée dans la cible.
  - Fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains → **rapport tumeur/tissu sain élevé**.

II. Dosimétrie en RIV

- **Différente de la RTE** : pas de relation simple entre l'activité administrée, la dose absorbée et l'effet.
- Nécessité de connaître au préalable la **biodistribution** : dans les tissus sains ; dans les tissus tumoraux (hétérogénéité).
- Idéalement pour la RIV : **une cible, un vecteur et 2 radionucléides** (c'est la base du théranostic).

III. Objectifs du théranostic

1. Déterminer la localisation et l'accessibilité d'une lésion étudiée à un agent thérapeutique potentiel.
2. Explorer la biodistribution d'un agent thérapeutique potentiel afin de prédire ses effets (+ ou −).
3. Déterminer la dose ou l'activité thérapeutique optimale à administrer.
4. Prédire la réponse au traitement.

IV. Sélection des candidats à la RIV

- **Le bon patient** : état général correct ; peu de comorbidités ou de traitements antérieurs pouvant favoriser une toxicité.

- **La bonne maladie** : maladie métastatique évolutive mais **pas flambante** ; pas trop tard.
- **Les bonnes lésions** : lésions surexprimant la cible ; écarter une hétérogénéité lésionnelle avec contingent peu différencié.

V. RIV en routine aujourd'hui (couples diagnostic / thérapie)

Indication	Diagnostic	Thérapie
1. CDT	^{131}I	^{131}I
2. NB / phéo / paragangliome	^{123}I-mIBG	^{131}I-mIBG
3. LNH	^{111}In-ibritumomab	^{90}Y-ibritumomab
4. TNE	DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE au ^{68}Ga, ou octréotide (^{111}In)	^{177}Lu-DOTATATE
5. Os	HMDP-^{99m}Tc	^{89}Sr, EDTMP-^{153}Sm ou radium 223
6. Foie	MAA-^{99m}Tc	Microsphères d'^{90}Y
7. Prostate	PSMA-^{68}Ga ou -^{18}F	PSMA-^{177}Lu, -^{225}Ac ou -^{213}Bi

VI. Douleur osseuse métastatique et RIV

1. MRP à visée osseuse

- Strontium 89 (^{89}Sr) → **Métastron** : émetteur β^-.
- Samarium 153 (^{153}Sm)-EDTMP → **Quadramet** : émetteur β^- et γ.
- Radium 223 (^{223}Ra) → **Xofigo** : émetteur α.

Paramètre	$^{89}SrCl_2$	^{153}Sm-EDTMP	$^{223}RaCl_2$
T½ (j)	**50,4**	**1,93**	**11,4**
Parcours (mm)	**2,4**	**0,6**	**< 0,1**
Dose (mCi)	**4**	**1/kg**	**0,001/kg/inj**
Dose (Bq)	**150 MBq**	**37 MBq/kg**	**55 kBq/kg/inj**
Début de l'effet (j)	**10–20**	**7–10**	Non évaluée
Durée de réponse (mois)	**6**	**4**	
Intervalle avant réinjection	**12 semaines**	**8 semaines**	1 injection/mois pendant **6 mois**

2. Émetteurs β^- : samarium 153 et strontium 89

A. Indications

1. Traitement des **douleurs osseuses dues à des métastases** :
   - Dans le cancer de la prostate : ^{89}Sr.
   - Dans les cancers en général : ^{153}Sm-EDTMP.
2. **Traitement palliatif +++** :
   - Concentration du traceur dans les zones se renouvelant beaucoup (irradiation des lésions avec épargne des zones saines).
   - Contrôle de la douleur et amélioration de la qualité de vie grâce à un traitement palliatif et alternatif aux analgésiques et à la RT.

B. Intérêts

1. Traitement de plusieurs sites simultanément.
2. Administration aisée.
3. Traitement répété possible.
4. Association possible avec d'autres traitements.

5. Contrôle des douleurs osseuses et ↓ du traitement analgésique.

a) et b) Les deux MRP

^{153}Sm-EDTMP (Quadramet) = biphosphonate + ^{153}Sm	^{89}Sr-chlorure (Métastron)
• Fixation du biphosphonate sur l'os en renouvellement. • Détection de la biodistribution possible : émetteur β^- et γ. • Élimination urinaire du produit dans les **6 premières heures** après injection → hospitalisation la journée pour recueil des urines. • Utilisé quel que soit le cancer à l'origine des métastases osseuses.	• Analogue du calcium. • Émetteur **β^- pur → pas d'imagerie**. • Le plus utilisé dans le monde. • **NB !** Utilisé seulement en cas de cancer prostatique métastatique.

C. Effets secondaires

1. **Exacerbation de la douleur** (à **24 h**, habituellement **72 h** post-injection) chez **10 %** des patients.
2. Douleur à l'injection → injection lente.
3. **Myélosuppression** (GB et plaquettes) :
   - Réversible spontanément si bilan hématologique initial correct.
   - Monitoring toutes les semaines, plus si nécessaire.
   - Retour aux paramètres initiaux en **1 à 3 mois**.

D. En pratique

Clinique

1. Métastases osseuses visualisées sur une scintigraphie osseuse de **< 2 mois**.
2. Corrélation douleurs / sites de métastases osseuses.
3. Plusieurs sites douloureux, donc RTE impossible ou difficile.
4. Pas de radiothérapie ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines**.

Laboratoire

1. Hb **> 9** ; neutrophiles **> 1 500** ; plaquettes **> 100 000**.
2. Clairance **> 50 mL/min**.

Contre-indications

1. Grossesse (test avant tout traitement et engagement à ne pas débuter de grossesse pendant **6 mois**).
2. Allaitement (arrêt définitif).
3. Clairance **< 30 mL/min** ou dialyse.
4. Compression médullaire, fracture pathologique, douleur neurologique.
5. *Super bone scan*.
6. Espérance de vie **≤ 4 semaines**.

3. Émetteur α : radium 223 « Xofigo »

- Analogue du calcium ; période : **11,4 j**.
- **Indications** : métastases osseuses douloureuses (antalgiques de niveau 2) de cancer de la prostate hormono-résistant.
- Injection IV tous les mois pendant **6 mois**.
- **Biodistribution du Xofigo** :
  - Capté par l'os (**44–77 %** 4 h après injection).
  - Éliminé par le **tube digestif +++**.
  - Reins et vessie peu irradiés.
- **Effets secondaires** : diminution des GB, GR et plaquettes ; troubles digestifs.
- **Bilan pré-thérapeutique** : FNS – plaquettes.

> **NB** — Contre-indications : **RCUH et maladie de Crohn**.

VII. Tableaux récapitulatifs

1. RIV en oncologie

Indication	MRP / nomenclature	T½	Énergie	Parcours	Activité	Efficacité	Dosimétrie
Irathérapie : CDT	Iodure de sodium ^{131}I	8 j	γ = 364 keV ; β = 606 keV	0,8 mm	30 mCi → 200 mCi	—	—
mIBG thérapeutique : NB stade III–IV ≥ 1 an ; phéo, paragangliome, carcinoïde (progression, M1…) ; CMT récurrent	Méta-iodo-benzyl-guanidine-^{131}I	idem	idem	idem	NB : 444 MBq/kg ; phéo : 100–500 mCi	NB : 35 % réponse, 50 % symptomatique ; phéo-Pg-carcinoïde : 70 % – 30 % – 5 % ; CMT : 20 %, 60 %	Tumeur : 5–300 Gy ; MO < 2 Gy
TNE : GEP bien différenciée, Krenning ≥ 2, SST2 ⊕	^{111}In-octréotide-DTPA	67 h	γ = 173–245 keV ; X = 23 keV ; Auger = 3 keV	Quelques µm	100 à 200 mCi (4 séances à 6–12 semaines d'intervalle)	Survie sans progression = 24 mois ; RP = 42 % ; ↓ symptômes + stabilité = 50 %	—
	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide (SSTR 2 > 3 > 5)	64 h	β^- = 2,27 MeV ; X de freinage (Bremsstrahlung)	11 mm			
	^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate (SSTR 2 > 4 > 5)	6,7 j	β^- = 0,49 MeV ; γ = 208 keV	2 mm			
PSMA : mCRPC avec SUVmax > 1,5 × SUV foie sur ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA	PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate = glutamate carboxypeptidase II) – ^{177}Lu	6,7 j	β^- = 0,49 MeV ; γ = 208 keV	2 mm	200 mCi/cycle ; 1 cycle / 6–8 semaines	↓ PSA ; ↓ douleur ; ↑ qualité de vie ; ↓ taille	2–9 Gy
	^{225}Ac-PSMA	10 j	α = 5,9 MeV	1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α ≈ 50–100 µm*	100 kBq/kg ; 1 cycle / 8 semaines		
Traitement des M+ osseuses = Xofigo : mCRPC + M+ os, pas de M1 viscérale, résistant au traitement systémique ou progressif	$^{223}RaCl_2$ (analogue du Ca^{2+})	11 j	α = 5 à 7 MeV	0,1 mm	55 kBq/kg ; 1 cycle/mois pendant 6 mois	↑ survie ; ↓ douleur ; ↑ qualité de vie	—
Traitement palliatif des métastases osseuses : multiples, ostéoblastiques ; jamais si SBS ; réfractaires ; récurrentes après RX	$^{89}SrCl_2$ (analogue du Ca^{2+}) — prostate +++	50 j	β^- = 1,4 MeV	2,4 mm	1 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : usuel 150 MBq (1,5–2,2 MBq/kg), cf. plus haut*	Comparable à la RX	—
	^{153}Sm-EDTMP (absorption sur les cristaux : débit, activité ostéoblastique)	2 j	β^- = 0,6 MeV ; γ = 103 keV	0,6 mm	37 MBq/kg	↓ douleur ; ↓ masse	
	^{186}Re-HEDP (idem)	3 j	β^- = 1 MeV ; γ = 137 keV	1 mm	1 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*	—	

2. RIV non oncologique

Indication	MRP / nomenclature	T½	Énergie	Parcours	Activité	Efficacité	Dosimétrie
Radiosynoviorthèse (épanchement) : – inflammatoire : rhumatoïde, SPA, psoriasique ; – non inflammatoire : hémarthrose, prothèse, arthrose active	^{90}Y = yttrium	64 h	β^- = 2,27 MeV ; X = freinage	11 mm	Varie en fonction de l'articulation : **2–6 mCi** ; 1 cure / 6 mois	≈ chirurgie, mais : ↓ coût ; répétitive ; ambulatoire ; ↓ risque hémorragique	—
	Sulfate de ^{186}Re	3 j	β^- = 1 MeV ; γ = 137 keV	1 mm			
	Erbium = citrate d'^{169}Er	9 j	β^- = 0,3 MeV ; γ = 80 keV	µm			
Hyperthyroïdie (TF > 5 %)	^{131}I-NaI = iodure de sodium	8 j	β^- = 606 keV ; γ = 364 keV	0,8 mm	Dosimétrique ou empirique	À 1 mois : FT4 ; à 3 mois : TSH + FT4	11 µSv/MBq

Hyperthyroïdie : détails du tableau

- **Étiologies listées** :
  - Hyperstimulation : TSH ; Ac = TRAK ; HCG.
  - Autonomie : génétique ; iode.
  - Amiodarone.
  - Thyroïdite : De Quervain ; radique.
  - HT = CDT ; factice.
  - HT = métastases ; ovaire.
- **Doses absorbées** : dose « antitoxique » = **60–90 Gy** ; dose ablative = **100–300 Gy**.
- ① **Méthode empirique** :

Critère	Catégorie	Activité (mCi)
Masse	< 30 g	**5–10**
	30–60 g	**10–15**
	> 60 g	**15–20**
Indication	Maladie de Basedow (MB)	**10–13,5**
	Nodule toxique (NT)	**13,5–15**
	GMNT	**15–20**

- ② **Méthode dosimétrique** : **A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × Teff × 0,04)**, avec Teff = **5,8 j**.
- **Suivi** : à 1 mois FT4 ; à 3 mois TSH + FT4 →
  - Euthyroïdie = bilan : guéri.
  - Hypothyroïdie (↓ T) = LT4.
  - Hyperthyroïdie persistante (↑ T) = ATS puis 2e cure d'iode (I2).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les qualités d'un vecteur idéal en RIV ?	Fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains (rapport tumeur/tissu sain élevé).
2. Pourquoi la dosimétrie en RIV diffère-t-elle de celle de la RTE ?	Pas de relation simple entre activité administrée, dose absorbée et effet ; il faut connaître la biodistribution (tissus sains et tumoraux, hétérogénéité).
3. Quels sont les 4 objectifs du théranostic ?	Localiser la lésion et son accessibilité ; explorer la biodistribution ; déterminer l'activité optimale ; prédire la réponse.
4. Intervalle avant réinjection : ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{223}Ra ?	12 semaines ; 8 semaines ; 1 injection/mois pendant 6 mois.
5. Pourquoi pas d'imagerie après ^{89}Sr ?	Émetteur β^- pur.
6. Prérequis biologiques avant palliation osseuse par ^{89}Sr / ^{153}Sm ?	Hb > 9, neutrophiles > 1 500, plaquettes > 100 000, clairance > 50 mL/min.
7. Quelle fraction de ^{223}Ra est captée par l'os et quelle est sa voie d'élimination ?	44–77 % à 4 h ; élimination par le tube digestif +++.
8. Activité empirique d'^{131}I selon l'indication de l'hyperthyroïdie ?	Basedow 10–13,5 mCi ; nodule toxique 13,5–15 mCi ; GMNT 15–20 mCi.